EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	Nº EGRESO	:	74521
SERVICIO	:	CIRUGIA HSC			
FECHA	:	2023-11-22 12:44:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ZOILA LUZ OCAMPO OCAMPO			RUN	: 4.269.189-5
F.Nac	: 12-10-1937	Edad	: 86 AÑOS, 1 MES	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 10-11-2023	Fecha Egreso	: 2023-11-22 12:44:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K46.0-HERNIA ABDOMINAL NO ESPEC., CON OBSTRUCCION, SIN GANGRENA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

HTA
ERC
CA MAMA OPERADO
COLEDOCOLITIASIS
COLELITIASIS
CLOSTRIDIUM DIFFICILE
DHC

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K40.0-HERNIA INGUINAL BILATERAL CON OBSTRUCCION, SIN GRANGRENA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE ACUDIO A URGENCIA EL DIA 10/11/23 POR CUADRO DE 2 DIAS DE EVOLUCION CARACTERIZADO POR CEG EN DOMICILIO Y FIEBRE HASTA 39°C
AL INGRESO SE EVIDENCIA ABDOMEN DISTENDIDO, IMPRESIONA A EXPENSAS DE LIQUIDO ASCITICO CON AUMENTO EN TRAMA VASCULAR EN HIPOGASTRIO
SE TOMA TAC DE ABDOME Y PELVIS C/C:
DHC CON HIPERTENSION PORTAL, ESPLENOMEGALIA, DESARROLLO DE CIRCULACION COLATERAL, EDEMA PARIETAL INTESTINAL Y ASCITIS
COLELITIASIS
COLEDOCOLITIASIS
ATEROMATOSIS CALCICA
QUISTE RENAL DERECHO
HERNIA HIATAL}
SE HOSPITALIZA CON DIAGNOSTICO DE HERNIA INGUINAL ESTRANGULADA, CON OBSTRUCCION SIN GANGRENA
INGRESA A PABELLON DONDE IMPRESIONA HERNIA INGUINAL DERECHA CON INTENSO PROCESO INFLAMATORIO, EDEMA HASTA LABIO MAYOR DERECHI
SACO HERNIARIO ENGROSADO, CON TRAYECTO INGUINAL RECTIFICADO.
SE REALIZO HERNIOTOMIA INGUINAL DERECHA
PACIENTE CON BUENA EVOLUCION CON RESPECTO A HERNIOPLASTIA, PERO INICIO CON DESPOISCIONES DISENTERICAS
SE TOMO MUESTRAS, CON RESULTADO + PARA TOXINAS C. DIFFICILE, HOY 6° DIA DE TRATAMIENTO CON VANCOMICINA ORAL
ACTUALMENTE PACIENTE EN BEG
TRANQUILA, SIN DOLOR
HEMODINAMICAMENTE ESTABLE, SIN APREMIO VENTILATORIO
AFEBRIL, TOLERANDO REGIMEN
DIURESIS+ DEPOSICIONES + SIN DIARREA

EX FISICO:
ALERTA, VIGIL, OTE
PIEL ROSADA, MUCOSAS HIDRATADAS, LLENE CAPILAR <2S
CARDIOPULMONAR: RR2T NAS. MP+ SRA
ABDOMEN: RHA+ ABDOMEN GLOBOSO, BLANDO, DEPRESIBLE, SIN SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL.
HERIDA EN BUENAS CONDICIONES, SIN SIGNOS DE INFECCION O NECROSIS.

PLAN DE MANEJO:

COMPLETAR 14 DIAS DE VANCOMICINA ORAL
CURACIONES POR HODOM
RETIRO DE PUNTOS A LOS 10 DIAS
CONTROL EN CAE DE CIRUGIA A LOS 21 DIAS
CONTROL EN CAE DE MED. INTERNA POR CLOSTRIDIUM Y PATOLOGÍAS DE BASE

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO, EVITAR REALIZAR FUERZA O LEVANTAR PESO
2. REGIMEN LIVIANO, HIPOSODICO DIABETICO
3. SE REALIZA ORDEN DE CPRE
4. PARACETAMOL CM 500 MG 2 comprimido cada 8 hrs. por 5 dias via ORAL
5. OMEPRAZOL CM 20 MG 1 comprimido cada 24 hrs. por 5 dias via ORAL
6. METOCLOPRAMIDA CM 10 MG 1 comprimido cada 8 hrs. por 5 dias via ORAL
7. CARVEDILOL CM 6,25 MG 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
8. VANCOMICINA AMPOLLA 500 MILÍGRAMOS 0.25 de ampolla cada 6 hrs. por 8 dias via ORAL

9. ANTIBIÓTICO POR HODOM
10. CURACIONES POR HODOM
11. RETIRO DE PUNTOSA LOS 10 DIAS POR HODOM
12. CONTROL EN CAE DE CIRUGIA A LOS 21 DIAS
13. CONTROL EN CAE DE MEDICINA INTERNA POR CLOSTRIDIUM, Y PATOLOGIAS DE BASE

NICOLÁS JAIME LETELIER ALARCÓN
MEDICO TRATANTE
17757150-4

JEFE SERVICIO